Amélioration de l'offre et l'accès aux services de santé de base pour les femmes et les enfants en milieu communautaire dans les zones à forts défis sécuritaires à travers les ASBC et AV dans les districts sanitaires de Dédougou et Solenzo.

Nom du présentateur : Dr Dénis BOGNINI

Auteurs et coauteurs : **Dénis BOGNINI, Sandrine KONSIMBO, Saidou DIPAMA, Bruno KI,**
Affiliations : Pathfinder International-Burkina

Plan

- Introduction
- Objectif
- Matériel et méthode(s)
- Résultats
- Conclusion

Introduction 1/2

- Pathfinder International met en œuvre plusieurs projets depuis 2013; Installation officielle en 2015;
- Projet Sauver La Vie (PSLV) financé par l'Ambassade des Pays-Bas couvre trois régions (BMHN, Nord et Centre Nord) à forts défis sécuritaires;
- soutient le programme national du MS axé sur la santé communautaire intitulé « Renforcer les services de santé primaires y compris la planification familiale (PF) pour accélérer les progrès vers la couverture sanitaire universelle »

Introduction 2/2

- La crise sécuritaire que connait le Burkina Faso depuis 2015 : fonctionnement à minima voire l'arrêt des activités de certaines formations sanitaires rendant difficile l'accès des populations impactées aux soins de qualité.
- Pour garantir un accès minimum aux soins et conseils en santé sexuelle et reproductive, les agents de santé à base communautaires (ASBC) et accoucheuses villageoises (AV) ont été mis à contribution;

Objectif

- **Objectif général**

Améliorer la santé maternelle et infantile des populations dans les zones à forts défis sécuritaire des districts sanitaires de Dédougou et Solenzo

- **Objectifs spécifiques**

Renforcer les connaissances et les compétences des acteurs communautaires sur :

- la planification familiale ;
- la prévention des infections ;
- les violences basées sur le genre (VBG) ;
- les directives d'autosoin ;
- la gestion des intrants ;
- la gestion des données sanitaires.

Soutenir les efforts des ASBC et des AV à jouer efficacement leur rôle de liaison entre les communautés et le système de soins

Matériel et méthode(s) 1/3

Matériel

- Formation des agents de santé à base communautaire sur la planification familiale: Guide du formateur;
- Document national d'orientation sur la délégation des tâches en SR/PF/VIH/Nutrition ;

Matériel et méthode(s) 2/3

Matériel

- Module de formation des accoucheuses villageoises/ASBC sur la délégation de tâches à la prise en charge intégrée de la santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, de la vaccination, de la nutrition et des violences basées sur le genre en situation d'urgence;
- Directives sur les autosoins.

Matériel et méthode(s) 3/3

- Identification des villages;
- Formations des ASBC et AV;
- Dotation en intrants et outils de collecte des données;
- Supervision délocalisée des activités;

Résultats 1/3

En deux ans de mise en œuvre:

- 30 acteurs communautaires (20ASBC et 10AV) formés et dotés en intrants et outils de collecte des données;
- 9532 personnes touchées par les causeries dont 593 sur la PF, 132 sur les SPN et 50 sur les CoPN;
- 2227 VAD réalisées;

Résultats 2/3

En deux ans de mise en œuvre:

- 7 supervisions délocalisées réalisées;
- 397 préservatifs masculins distribués;
- 178 Sayana press administrés;
- 61 plaquettes de pilules distribuées;

Résultats 3/3

En deux ans de mise en œuvre:

- 75 clientes référées dans les FS pour les MLDAP;
- **17 accouchements réalisés à domicile sous l'assistance des AV;**
- **17 femmes perdues de vue retrouvées par les acteurs communautaires;**
- **12 NNE prise en charge par les ASBC et 4 référés dans les FS.**

Conclusion

- La contribution des ASBC/AV est une solution déterminante pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale dans le contexte difficile que traverse le pays.
- Pour la couverture sanitaire universelle le rôle des acteurs communautaires n'est pas à ignorer et doit être mieux organisé.

Merci pour votre attention